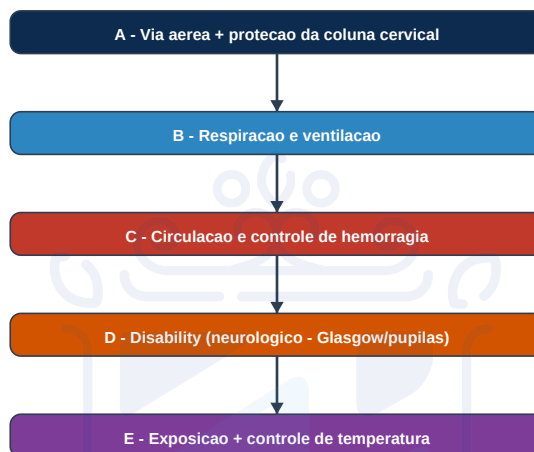


ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMA — ABCDE

FLUXOGRAMA — AVALIAÇÃO PRIMÁRIA (ATLS)

TRAUMA — SEQUÊNCIA ABCDE



PRINCÍPIO (ATLS 11a ed.)

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

- Padronização universal do atendimento inicial à vítima de trauma
- Sequência ABCDE: identificar e tratar o que mata PRIMEIRO, na ordem
- Tratar cada problema ameaçador à vida ASSIM que identificado, antes de seguir
- Reavaliar continuamente (a deterioração obriga a recomeçar pelo A)

A — VIA AÉREA E COLUNA CERVICAL

PROTEGER VIA AÉREA + COLUNA

- Ofertar O₂ 15 L/min em máscara não reinalante; conversar com o paciente (responde = via aérea pérvia)
- Sinais de via aérea ameaçada: trauma de face grave, hemorragia oral/nasal incontrolável, hipóxia, TCE com Glasgow < 8
- Via aérea DEFINITIVA: IOT (preferencial); cricotireoidostomia cirúrgica se IOT inviável
- Manter COLAR CERVICAL e head-block (estabilização) até excluir lesão de coluna
- Aspirar secreções/sangue; atenção a corpos estranhos e fraturas de face

B — RESPIRAÇÃO (perigos que matam no B)

DIAGNÓSTICO CLÍNICO -> CONDUTA IMEDIATA

- Exame: ausculta, percussão e palpação torácica + SatO₂
- Pneumotórax HIPERTENSIVO: descompressão imediata (não esperar RX)
- Pneumotórax ABERTO: curativo de 3 pontas
- Hemotórax MACIÇO: drenagem + reposição/toracotomia
- Tamponamento cardíaco e hérnia diafragmática traumática também se identificam no B

C — CIRCULAÇÃO E CONTROLE DE HEMORRAGIA

Rx FOCOS E REPOSIÇÃO

Avaliar focos de sangramento: TÓRAX, ABDOME, PELVE, ossos longos e 'chão' (externo)

Sinais: FC, PA, perfusão periférica, nível de consciência, diurese

2 acessos venosos periféricos CALIBROSOS

Ringer Lactato AQUECIDO (~39 C) 1000 mL; reavaliar resposta

Indicar hemotransfusão precoce conforme classe de choque (controle de dano); ácido tranexâmico se indicado

Comprimir hemorragias externas; estabilizar pelve (cinta) se suspeita de fratura instável

D — NEUROLÓGICO e E — EXPOSIÇÃO

D — DISABILITY

- Escala de Coma de Glasgow
- Reatividade e simetria pupilar
- Déficits neurológicos focais
- Excluir confundidores: hipoglicemia (HGT!), álcool/drogas, doença neurológica de base

E — EXPOSIÇÃO

- Despir o paciente totalmente para avaliação
- Rolamento em bloco (avaliar dorso/coluna)
- Controle de temperatura: aquecimento ativo e passivo
- Fluidos aquecidos + manta térmica (evitar a tríade letal)

CONCEITO — TRÍADE LETAL E REAVALIAÇÃO

NÃO DEIXAR ESFRIAR

- Tríade letal: HIPOTERMIA + ACIDOSE + COAGULOPATIA (alimenta-se e fecha o ciclo da morte)
- Por isso: fluidos aquecidos, controle precoce do sangramento e ressuscitação balanceada (hemocomponentes)
- Após o ABCDE primário, fazer adjuntos (FAST, RX, sondas) e avaliação secundária (head-to-toe)
- Qualquer deterioração -> REINICIAR pelo A
- Hipotensão no trauma é HEMORRÁGICA até prova em contrário

CHECKLIST DA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

NÃO ESQUECER

- ☐ A: via aérea pérvia/definitiva + colar cervical
- ☐ B: excluir pneumotórax hipertensivo/aberto, hemotórax maciço, tamponamento
- ☐ C: 2 acessos calibrosos, controlar hemorragia, RL aquecido, transfusão conforme choque
- ☐ D: Glasgow, pupilas, HGT
- ☐ E: exposição + aquecimento; depois adjuntos (FAST/RX/sondas) e secundária

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Politraumatizado por ____ (mecanismo). A: ____ (pérvia/IOT). B: ____ . C: PA/FC ____, classe de choque ____.
- D: Glasgow ____, pupilas ____. E: lesões identificadas ____; aquecido.
- Condutas: acessos, RL aquecido ____ mL, transfusão ____, descompressão/dreno ____, cinta pélvica ____.
- Solicito transferência para centro de trauma (cirurgia/UTI) — estabilizar antes de transferir.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

No atendimento ABCDE, paciente com TCE e Glasgow 7. Qual a conduta na etapa A?

- A) Aguardar a tomografia antes de qualquer medida
- B) Via aérea definitiva (intubação orotraqueal) com proteção da coluna cervical
- C) Apenas oxigênio em cateter nasal
- D) Iniciar a avaliação pela circulação
- E) Administrar manitol antes de proteger a via aérea

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quais diagnósticos ameaçadores à vida devem ser identificados e tratados ainda na etapa B (respiração)?

- A) Fratura de fêmur isolada
- B) Pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax maciço e tamponamento cardíaco
- C) Lesão de extremidade
- D) Hipoglicemia
- E) Laceração de couro cabeludo

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a conduta inicial de reposição volêmica na etapa C do ATLS?

- A) Soro glicosado a 5% em grande volume
- B) Ringer lactato aquecido (~39 C) com 2 acessos calibrosos e transfusão conforme a classe de choque
- C) Restrição hídrica absoluta
- D) Apenas coloides
- E) Aguardar tipagem sanguínea antes de qualquer acesso

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual conjunto compõe a 'tríade letal' do trauma?

- A) Febre, leucocitose e taquicardia
- B) Hipotermia, acidose e coagulopatia
- C) Hipertensão, bradicardia e apneia
- D) Hiperglicemia, hipernatremia e desidratação
- E) Dor, edema e equimose

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Na etapa D, qual confundidor deve ser SEMPRE descartado por uma medida simples à beira-leito?

- A) Hipertensão intracraniana por TC
- B) Hipoglicemia (HGT capilar)
- C) Hipotireoidismo por TSH
- D) Anemia por hemograma
- E) Hipocalcemia por cálcio iônico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Glasgow ≤ 8 indica via aérea definitiva: IOT com proteção da coluna cervical (estabilização em linha). O 'A' do ATLS prioriza a via aérea antes de prosseguir; não se aguarda a TC para protegê-la.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

No 'B', identificam-se e tratam-se imediatamente: pneumotórax hipertensivo (descompressão), pneumotórax aberto (curativo 3 pontas), hemotórax maciço (drenagem/toracotomia) e tamponamento cardíaco.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A reposição inicial é Ringer lactato AQUECIDO por 2 acessos calibrosos, indicando hemotransfusão precoce conforme a classe de choque (estratégia de controle de dano, ressuscitação balanceada).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A tríade letal do trauma é hipotermia + acidose + coagulopatia, que se retroalimentam. Preveni-la (fluidos aquecidos, controle do sangramento, hemocomponentes) é central no controle de dano.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na etapa D, a hipoglicemia deve ser descartada com o HGT capilar — é causa tratável e frequente de rebaixamento que confunde o quadro neurológico do trauma.

SM24
Suporte ao Plantão Médico